

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENYULUHAN PENGARUH *HOME PHARMACY CARE* TERHADAP PENYAKIT TUBERKULOSIS DI MASA PANDEMI COVID-19



TIM PENGABDIAN

apt. Eleonora Maryeta T., M. Farm	NIDN 0615039301 / Ketua
apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	NIDN 0617107902 / Anggota
apt. Metrikana Novembrina, M.Sc	NIDN 0619118601 / Anggota
Margaretha Hendrika Helmina Leong	NIM A1192135 / Anggota
Theresia Chlarita Lavanto	NIM A1192136 / Anggota

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG**

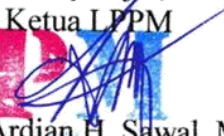
2021

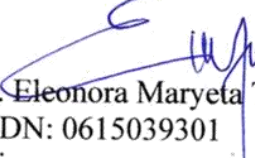
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat: Penyuluhan Pengaruh *home pharmacy care*
Terhadap Penyakit Tuberkulosis di Masa
Pandemik Covid-19

Ketua Pengabdi	
Nama Lengkap	: apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
NIDN/NIP	: 0615039301
Jabatan Fungsional	: -
Program Studi	: DIII Farmasi
Nomor HP	: 085336094055
Alamat email	: eleonorareth@gmail.com
Anggota Pengabdi (1)	
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
NIDN/NIP	: 0617107902 /-
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Anggota Pengabdi (2)	
Nama Lengkap	: apt. Metrikana Novembrina, M.Sc
NIDN/NIP	: 0619118601 / 071115020
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Anggota Pengabdi (3)	
Nama Lengkap	: Margaretha Hendrika H. Leong
NIM	: A1192135
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Anggota Pengabdi (4)	
Nama Lengkap	: Theresia Chlarita Lavanto
NIM	: A1192136
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Dana yang diusulkan	: Rp 3.000.000,00

Semarang, 11 Juni 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

apt. Rizky Ardian H. Sawal, M. Farm
NIDN: 0620029301

Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat,

apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
NIDN: 0615039301

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera


apt. Yithro Serang, M. Farm
NIDN: 0601069001



DAFTAR ISI

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. ANALISIS SITUASI	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN KEGIATAN.....	8
D. MANFAAT KEGIATAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tuberkulosis	9
1. Pengertian	9
2. Patogenesis tuberkulosis	9
3. Penularan tuberkulosis	10
4. Gejala tuberkulosis	11
5. Pengobatan tuberkulosis	12
B. Upaya Pencegahan Tuberkulosis.....	13
BAB III METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
A. Tempat dan Waktu Pengabdian Kepada Masyarakat.....	16
B. Jumlah Peserta Pengabdian	16
C. Metode Kegiatan	16
BAB IV ALOKASI ANGGARAN DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Error! Bookmark not defined.
A. Anggaran Biaya	Error! Bookmark not defined.

B. Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat .**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA22

LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

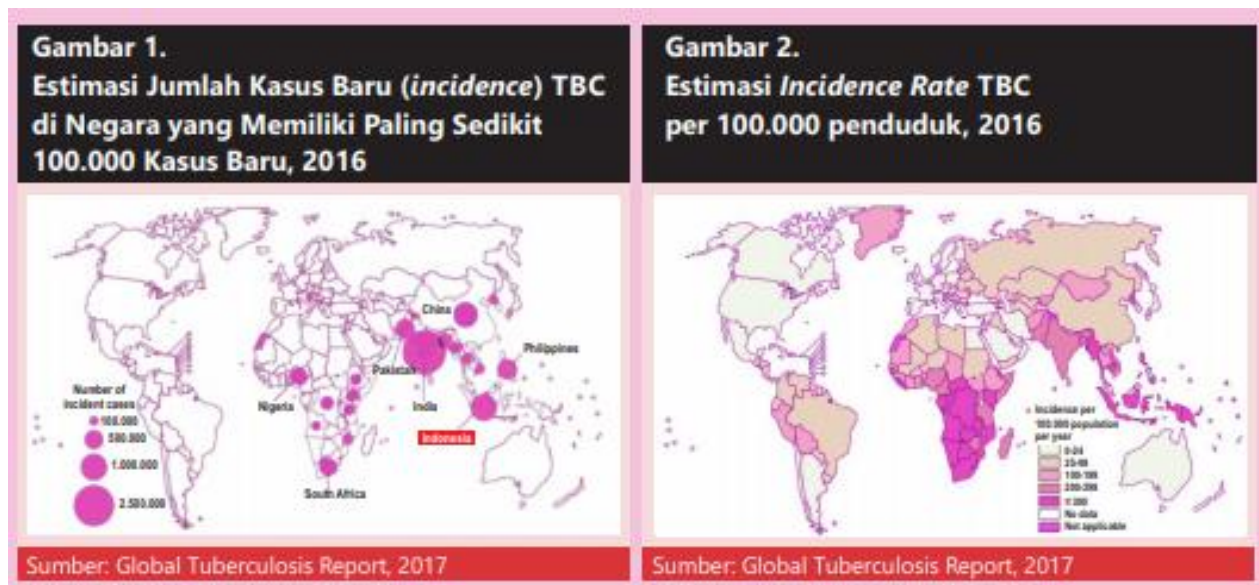
BAB I

PENDAHULUAN

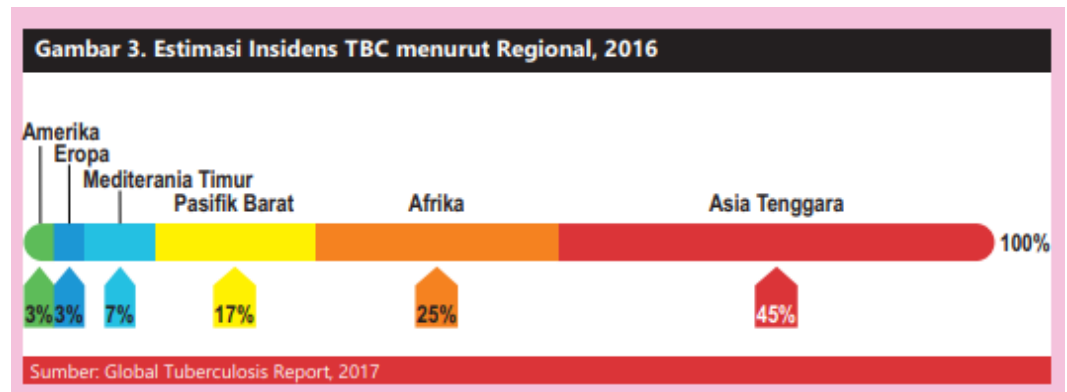
A. ANALISIS SITUASI

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan bersifat menular (Storla et al., 2008). Terdapat spesies *Mycobacterium* antara lain: *M. tuberculosis*, *M. africanum*, *M. bovis*, *M. Leprae* yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA) sebagai penegak diagnosis dan pengobatan TBC.

Secara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 kasus insiden TBC yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. Lima negara insiden kasus tertinggi yaitu India, Indonesia, China, Philipina, dan Pakistan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini;



Sebagian besar estimasi insiden TBC pada tahun 2016 di kawasan Asia Tenggara (45%), dimana Indonesia merupakan salah satu di dalamnya dan 25% terjadi di kawasan Afrika pada gambar 3 berikut ini.



World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa negara dengan beban tinggi untuk TBC berdasarkan 3 indikator yaitu TBC, TBC/HIV, dan MDR-TBC. Terdapat 48 negara yang masuk dalam daftar tersebut. Indonesia bersama 13 negara lain, masuk dalam daftar HBC untuk 3 indikator tersebut, yang artinya Indonesia memiliki permasalahan besar dalam menghadapi penyakit TBC (Kemenkes RI, 2019).

Jumlah kasus baru TB di Indonesi sebanyak 420.994 kasus pada tahun 2017. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru TBC pada laki-laki 1,4 kali lebih besar dibandingkan pada perempuan. Begitu juga terjadi di negara-negara lain, karena kemungkinan laki-laki lebih terpapar pada risiko TBC misalnya merokok dan kurangnya ketidakpatuhan minum obat. Survei ini menemukan bahwa dari seluruh partisipan laki-laki yang merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% partisipan perempuan yang merokok.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang harus dicegah dan dikendalikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien TB dengan cara:

1. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
2. Membudayakan perilaku berbatuk
3. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat
4. Peningkatan daya tahan tubuh
5. Penanganan penyakit penyerta TBC

6. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan di luar fasilitas pelayanan kesehatan

Adapun pilar dan komponen penanggulangan TBC diuraikan sebagai berikut;

- a. Integrasi layanan TBC pada pasien dan upaya pencegahan TBC
 - i. Diagnosis TBC sedini mungkin, termasuk uji kepekaan OAT bagi semua dan penapisan TBC secara sistematis bagi kontak dan kelompok populasi berisiko tinggi
 - ii. Pengobatan untuk semua pasien TBC, termasuk untuk penderita resisten obat dengan disertai dukungan yang berpusat pada kebutuhan pasien
 - iii. Kegiatan kolaborasi TB/HIV dan tatalaksana komorbid TBC yang lain
 - iv. Upaya pemberian pengobatan pencegahan pada kelompok rentan dan berisiko tinggi serta pemberian vaksinasi untuk mencegah TBC
- b. Kebijakan sistem pendukung yang berani dan jelas
 - i. Komitmen politis yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan layanan dan pencegahan TBC
 - ii. Keterlibatan aktif masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan pemberi layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
 - iii. Penerapan layanan kesehatan semesta dan kerangka kebijakan lain yang mendukung pengendalian TBC, seperti wajib lapor, registrasi vital, tata kelola dan penggunaan obat rasional serta pengendalian infeksi
 - iv. Jaminan sosial, pengentasan, kemiskinan dan kegiatan lain untuk mengurangi dampak determinasi sosial terhadap TBC

c. Intensitas riset dan inovasi

- i. Penemuan, pengembangan dan penerapan secara alat, metode intervensi dan strategi baru pengendalian TB
- ii. Pengembangan riset untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan merangsang inovasi-inovasi baru untuk mempercepat pengembangan program pengendalian TB

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengetahui pengaruh *home pharmacy care* terhadap penyakit tuberkulosis di masa pandemik COVID-19 dengan melakukan informasi penyakit, konseling pasien, pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat dan *home care*.

D. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat kegiatan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan atau wawasan masyarakat tentang penggunaan obat TB dalam mencegah infeksi *Mycobacterium tuberculosis*
2. Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam penggunaan obat TB
3. Menjalin relasi dengan baik antara institusi STIFERA dengan masyarakat di Ds. Kalisegoro, RT 03 / RW 02, Gunungpati, Semarang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tuberkulosis

1. Pengertian

Tuberkulosis (TBC) paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman *Mycrobacterium tuberculosis* yang menyerang paru-paru dan bronkus. TBC paru tergolong penyakit air borne infection, yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernapasan ke dalam paru-paru. Kemudian kuman menyebar dari paru-paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, melalui bronkus atau penyebaran langsung ke bagian tubuh lainnya (Kusumaningroh et al., 2018).

Tuberkulosis (TBC) paru adalah suatu penyakit infeksi kronis yang sudah sangat lama dikenal pada manusia, misalnya dia dihubungkan dengan tempat tinggal di daerah urban, lingkungan yang padat, dibuktikan dengan adanya penemuan kerusakan tulang vertebra otak yang khas TBC dari kerangka yang digali di Heidelberg dari kuburan zaman neolitikum, begitu juga penemuan yang berasal dari mumi dan ukuriran dinding piramid di Mesir kuno pada tahun 2000-4000 SM. Hipokrates telah memperkenalkan sebuah terminologi yang diangkat dari bahasa Yunani yang menggambarkan tampilan penyakit TBC paru ini (Beelt et al., 2014).

2. Patogenesis tuberkulosis

Kuman *Mycobacterim Tuberculosis* masuk kedalam tubuh melalui pernafasan kemudian basil tuberkel yang mencapai permukaan alveolus menyebabkan reaksi peradangan, tubuh mencoba bereaksi melalui leukosit polimorfonuklear memfagosit bacteria namun tidak membunuh organisme tersebut sehingga sampai menyerang alveoli. Alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi maka muncul gejala pneumonia akut dan bakteri terus di fagosit dan berkembang dalam sel sehingga ada yang sembuh dengan

sendirinya namun ada yang menyebar melalui getah bening menuju ke kelenjar bening regional yang menyebabkan TBC.

3. Penularan tuberkulosis

Menurut (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2017) cara penularan penyakit Tuberkulosis adalah

- a. Sumber penularan adalah pasien TBC BTA positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. Namun, bukan berarti bahwa pasien TBC dengan hasil pemeriksaan BTA negatif tidak mengandung kuman dalam dahaknya. Hal tersebut bisa saja terjadi karena jumlah kuman yang terkandung dalam contoh uji $\leq$ dari 5.000 kuman/ccdahak sehingga sulit dideteksi melalui pemeriksaan mikroskopis langsung.
- b. Pasien TBC dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TBC. Tingkat penularan pasien TBC BTA positif adalah 65%, pasien TBC BTA negatif dengan hasil kultur positif adalah 26% sedangkan pasien TBC dengan hasil kultur negatif dan foto toraks positif adalah 17%.
- c. Infeksi akan terjadi apabila orang lain menghirup udara yang mengandung percik renik dahak yang infeksius tersebut.
- d. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei / percik renik). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak.

Kuman TBC menyebar melalui udara saat si penderita batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Yang hebat, kuman ini dapat bertahan di udara selama beberapa jam. Perlu diingat bahwa TBC tidak menular melalui berjabat tangan dengan penderita TBC, berbagi makanan/minuman, menyentuh seprai atauudukan toilet, berbagi sikat gigi, bahkan berciuman (American Journal of Sociology, 2019). Lingkungan hidup yang sangat padat dan pemukiman di wilayah perkotaan yang kurang memenuhi persyaratan kemungkinan besar telah mempermudah proses penularan dan berperan sekali atas peningkatan jumlah kasus TBC. Penularan penyakit ini sebagian besar

melalui inhalasi basil yang mengandung droplet nuclei, khususnya yang didapat dari pasien TB paru dengan batuk berdarah atau berdahak yang mengandung basil tahan asam (BTA) (Kusumaningroh et al., 2018).

4. Gejala tuberkulosis

- a. Gejala sistemik atau umum
 - i. Demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam kadang-kadang serangan dalam seperti influenza dan bersifat hilang-timbul.
 - ii. Penurunan nafsu makan dan berat badan
 - iii. Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu (dapat disertai dengan darah)
- b. Perasaan tidak enak (malaise), lemah (Kenedyanti & Sulistyorini, 2017).
- c. Gejala khusus
 - i. Tergantung dari organ tubuh mana yang terkena, bila terjadi sumbatan sebagian bronkus (saluran yang menuju ke paru-paru) akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara nafas melemah yang disertai sesak.
 - ii. Kalau ada cairan di rongga pleura (pembungkus paru-paru), dapat disertai dengan keluhan sakit dada.
 - iii. Bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit atasnya, pada muara ini akan keluar cairan nanah.
 - iv. Pada anak-anak dapat mengenai otak (lapisan pembungkus otak) dan disebut sebagai meningitis (radang selaput otak), gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang

5. Pengobatan tuberkulosis

Terdapat enam macam obat esensial yang telah dipakai sebagai berikut : Isoniazid (H), para amino salisilik asid (PAS), Streptomisin (S), Etambutol (E), Rifampisin (R) dan Pirazinamid (P). Faktor-faktor risiko yang sudah diketahui menyebabkan tingginya prevalensi TBC di Indonesia antara lain : kurangnya gizi, kemiskinan dan sanitasi yang buruk (Pradani & Kundarto, 2018).

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut:

- a. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.
- b. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).
- c. Pengobatan TBC diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan.
 1. Tahap awal (intensif)
 - i. Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat.
 - ii. Pengobatan tahap intensif tersebut apabila diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu.
 - iii. Sebagian besar pasien TBC BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan.
 2. Tahap lanjutan
 - i. Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama

ii. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan, 2014)

B. Upaya Pencegahan Tuberkulosis

Tindakan pencegahan dapat dikerjakan oleh penderitaan, masyarakat dan petugas kesehatan.

a. Pengawasan penderita, kontak dan lingkungan

- 1) Oleh penderita, dapat dilakukan dengan menutup mulut sewaktu batuk dan membuang dahak tidak disembarangan tempat.
- 2) Oleh masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan dengan terhadap bayi harus diberikan vaksinasi BCG (Bacillus Calmete Guerin).
- 3) Oleh petugas kesehatan dengan memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC yang antara lain meliputi gejala bahaya dan akibat yang ditimbulkannya.
- 4) Isolasi, pemeriksaan kepada orang-orang yang terinfeksi, pengobatan khusus TBC. Pengobatan mondok dirumah sakit hanya bagi penderita yang kategori berat yang memerlukan pengembangan program pengobatannya yang karena alasan-alasan sosial ekonomi dan medis untuk tidak dikehendaki pengobatan jalan.
- 5) Desinfeksi, Cuci tangan dan tata rumah tangga keberhasilan yang ketat, perlu perhatian khusus terhadap muntahan dan ludah (piring, tempat tidur, pakaian) ventilasi rumah dan sinar matahari yang cukup.
- 6) Imunisasi orang-orang kontak. Tindakan pencegahan bagi orang-orang sangat dekat (keluarga, perawat, dokter, petugas kesehatan lain) dan lainnya yang terindikasinya dengan vaksi BCG dan tindak lanjut bagi yang positif tertular.

- 7) Penyelidikan orang-orang kontak. Tuberculin-test bagi seluruh anggota keluarga dengan foto rontgen yang bereaksi positif, apabila cara-cara ini negatif, perlu diulang pemeriksaan tiap bulan selama 3 bulan, perlu penyelidikan intensif.
- 8) Pengobatan khusus. Penderita dengan TBC aktif perlu pengobatan yang tepat obat-obat kombinasi yang telah ditetapkan oleh dokter di minum dengan tekun dan teratur, waktu yang lama (6 atau 12 bulan). Diwaspadai adanya kebal terhadap obat-obat, dengan pemeriksaan penyelidikan oleh dokter.

b. Tindakan pencegahan

- 1) Status sosial ekonomi rendah yang merupakan faktor menjadi sakit, seperti kepadatan hunian, dengan meningkatkan pendidikan kesehatan. 15
- 2) Tersedia sarana-sarana kedokteran, pemeriksaan penderita, kontak atau suspect gambas, sering dilaporkan, pemeriksaan dan pengobatan dini bagi penderita, kontak, suspect, perawatan.
- 3) Pengobatan preventif, diartikan sebagai tindakan keperawatan terhadap penyakit inaktif dengan pemberian pengobatan INH (Isoniazid) sebagai pencegahan.
- 4) BCG, vaksinasi diberikan pertama-tama kepada bayi dengan perlindungan bagi ibunya dan keluarganya. Diulang 5 tahun kemudian pada 12 tahun ditingkat tersebut berupa tempat pencegahan.
- 5) Memberantas penyakit TBC pada pemerah air susu dan tukang potong sapi dan pasteurisasi air susu sapi
- 6) Tindakan mencegah bahaya penyakit paru kronis karena menghirup udara yang tercemar debu para pekerja tambang, pekerja semen dan sebagainya.

- 7) Pemeriksaan bakteriologis dahak pada orang dengan gejala TBC paru.
- 8) Pemeriksaan screening dengan tuberculin test pada kelompok beresiko tinggi, seperti para emigrant, orang-orang kontak dengan penderita, petugas dirumah sakit, petugas/guru disekolah, petugas foto rontgen.
- 9) Pemeriksaan foto rontgen pada orang-orang yang positif dari hasil pemeriksaan tuberculin tes.

BAB III

METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tempat dan Waktu Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Ds. Kalisegoro, RT 03 / RW 02, Gunung Pati, Semarang. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai selesai.

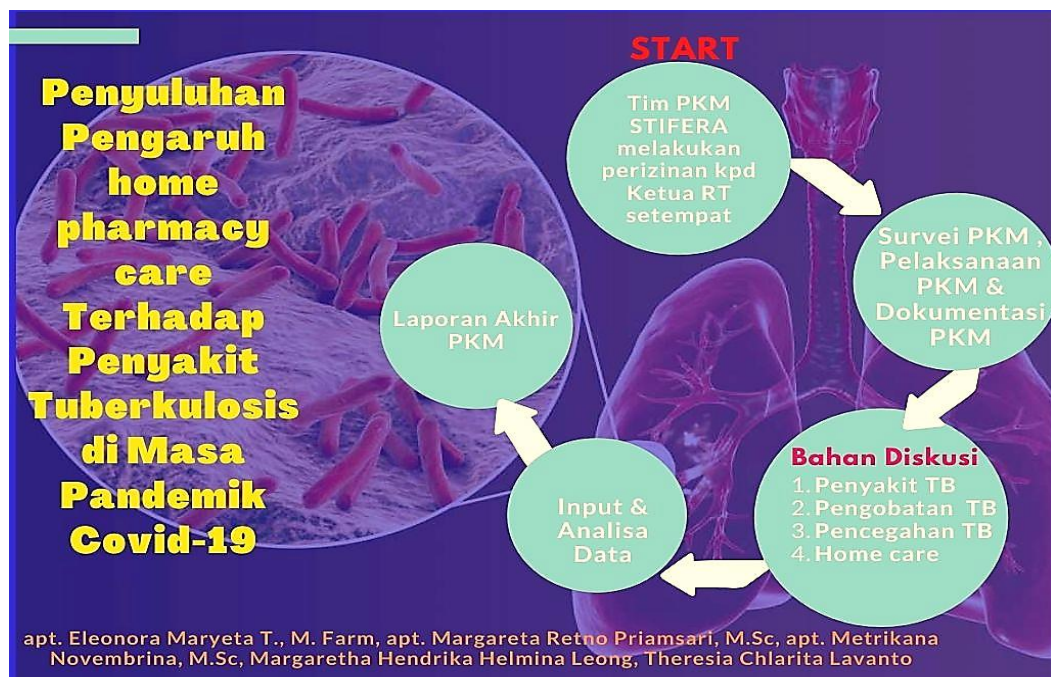
B. Jumlah Peserta Pengabdian

Jumlah peserta sekitar 30 yaitu ibu-ibu PKK, Ds. Kalisegoro, RT 03 / RW 02, Gunungpati, Semarang

C. Metode Kegiatan

Rancangan pengabdian kepada masyarakat adalah potong lintang dengan pendekatan kualitatif terhadap ibu-ibu PKK. Pengumpulan data dengan cara diskusi kelompok terarah tentang penyakit tuberkulosis, penyebab dan pencegahan tuberkulosis, serta pengobatan tuberkulosis dan *home care*.

Skema kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Skema Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyakit tuberkulosis (TB) paru masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. TB atau yang dikenal TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Risiko penularan setiap tahun yang dihitung dari indikator *Annual Risk of Tuberculosis Infection* (ARTI) di Indonesia dianggap cukup tinggi dan bervariasi antara 1-3%. Global Report *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2019 setiap hari, lebih dari 4000 orang meninggal karena TB dan hampir 30.000 orang jatuh sakit karena terinfeksi penyakit TB (Phillips, 2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penularan TB meliputi karakteristik individu, keadaan gizi, perilaku, daya tahan tubuh rendah, lingkungan rumah, lingkungan kerja, dan sosial ekonomi (Ernawati et al., 2017).

Penyakit TB saat ini masih menjadi beban masalah kesehatan, dimana Indonesia juga menghadapi wabah corona atau yang biasa disebut Covid-19. Virus corona ini harus lebih diwaspadai oleh pasien TB. Kedua penyakit ini merupakan pandemi pernafasan yang menular melalui droplet atau percikan yang dapat menyerang segala rentang usia, dan orang yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti kronis pada paru, bahkan pada anak-anak.

Penularan TB dan Covid-19 sama-sama melalui droplet, namun perbedaannya adalah pada diagnosisnya. Covid-19 berasal dari virus, sedangkan TB berasal dari kuman atau bakteri. Selanjutnya pada gejala Covid-19 antara lain; onset akut kurang dari 14 hari yang disertai demam lebih dari 38⁰C dengan batuk kering, sesak nafas, nyeri sendi, pilek, nyeri kepala, gangguan penciuman atau pengecap. Sedangkan TB, onset atau serangan kronik lebih dari 14 hari dengan gejala demam kurang dari 38⁰C disertai batuk berdahak, bercak darah, sesak nafas memberat bertahap, berat badan turun, dan berkeringat di malam hari.

Proses diagnosis TB dan Covid-19 juga memiliki kesamaan dengan menggunakan metode tes cepat molekuler (TCM) dan *polymerase chain reaction* (PCR), namun perbedaannya ada pada pengambilan sampel. Untuk

diagnosa Covid-19 harus melalui swab, sedangkan TB cukup dengan pengambilan dahak saja. Selain itu, perbedaan besar antara Covid-19 dengan TB adalah Covid-19 belum ada obat yang dapat menyembuhkan, sedangkan TB sudah ditemukan obatnya dan dapat diakses secara gratis. Walaupun memiliki obat dalam membantu penyembuhan, masih banyak masyarakat yang menyepelekan penyakit TB karena dianggap merupakan penyakit lama sehingga kurang memperhatikan kedisiplinan pada proses penyembuhan melalui konsumsi obat yang telah tersedia, sehingga para penderita TB menjadi resisten atau obatnya sudah tidak mempan lagi terhadap kuman bakteri TB.

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera (STIFERA) merupakan sekolah tinggi yang bergerak di bidang kefarmasian. Salah satu misi yang harus dilakukan adalah “Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat” sebagai bentuk implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu dengan misi yang diketahui, apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm melihat bahwa STIFERA perlu membantu pemerintah dalam penanganan wabah pandemi Covid-19. Kontribusi STIFERA adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang Penyuluhan Pengaruh *Home Pharmacy Care* Terhadap Penyakit Tuberkulosis di Masa Pandemi Covid-19.

STIFERA melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK di Ds. Kalisegoro, RT 03 / RW 02, Gunung Pati, Semarang, pada hari Minggu 30 Mei 2021, pukul 10.00 WIB sampai selesai. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian beberapa hal penting tentang penyakit tuberkulosis diantaranya; penyebab dan gejala, cara penularan, faktor risiko, dan cara pencegahan TB. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang TB pada masa pendemi Covid-19, sehingga diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap pasien TB dan dapat meningkatkan kesadaran untuk ikut serta dalam penanggulangan TB dan Covid-19.



Gambar 2. Pengecekan suhu dan pemberian *hansanitizer*

Mekanisme penyuluhan penyakit TB pada masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut;

- ✓ Semua peserta tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
- ✓ Peserta datang, mencuci tangan dan dicek suhunya menggunakan *Thermogun*.
- ✓ Registrasi dengan mengisi nama lengkap dan paraf sebagai kesahihan
- ✓ Pembagian brosure
- ✓ Dibuka kegiatan penyuluhan kegiatan oleh moderator
- ✓ Pemaparan materi oleh Ketua PKM sebagai narasumber
- ✓ Diskusi dan tanya jawab
- ✓ Sesi terakhir penutupan dengan melakukan penyerahan souvenir dan foto bersama ibu-ibu PKK.



Gambar 3. Kegiatan penyuluhan Penyakit Tuberkulosis

Kegiatan penyuluhan ini, kita diajak untuk peduli terhadap penyakit TB, mengenal betapa berbahayanya dan mematikan penyakit tersebut. Kita juga perlu mengetahui sistem penularan dan bagaimana cara mengantisipasi pencegahan dan penyebaran penyakit TB, serta prosedur pengobatan apabila ada yang terinfeksi TB ataupun terpapar Covid-19. Dan diharapkan tetap berperilaku hidup bersih dan sehat serta menaati himbauan dari pemerintah untuk upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis yang meliputi; penyebab dan gejala, cara penularan, faktor risiko, dan cara pencegahan TB
2. Dapat menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- American Journal of Sociology. (2019). Faktor Tb. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Beelt, M., Ismanto, Y., & Kallo, V. (2014). HUBUNGAN KEPATUHAN PENGOBATAN DENGAN HILANGNYA GEJALA KLINIS TUBERKULOSIS PARU DI POLI PARU RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*.
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2017). Profil Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Dinas Kesehatan*, 163.
- Ernawati, K., Rifqatussa'adah, Wulansari, R., Damayanti, N. A., & Djannatun, T. (2017). Penyuluhan Cara Pencegahan Penularan Tuberkulosis dan Pemakaian Masker di Keluarga Penderita: Pengalaman dari Johor Baru, Jakarta Pusat. *Berita Kedokteran Masyarakat (BKM Journal of Community Medicine and Public Health)*, 34 Nomor 1, 44–49.
- Kemenkes RI. (2019). *Situasi TBC di Indonesia*. <https://Tbindonesia.or.Id>.
- Kenedyanti, E., & Sulistyorini, L. (2017). Analisis Mycobacterium Tuberkulosis dan Kondisi Fisik Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(2), 152–162. <https://doi.org/10.20473/jbe.v5i2.2017.152-162>
- Kusumaningroh, D., Susilowati, T., & Wulandari, R. (2018). The Correlation of Physical Activity and Treatment Phase with Nutritional Status on Patients Of Lungs Tuberculosis. *Jurnal Ners Dan Kebidanan*, 1–7. <https://doi.org/10.26699/jnk.v5i1.ART.p001>
- Phillips, J. A. (2015). Global Tuberculosis. *Workplace Health and Safety*, 63(10), 476. <https://doi.org/10.1177/2165079915607875>
- Pradani, S. A., & Kundarto, W. (2018). Evaluasi Ketepatan Obat dan Dosis Obat Anti Tuberkulosis pada Pasien Anak Di Instalasi Rawat Jalan RSUDDr. Moewardi Surakarta Periode 2016-2017. *JPSCR : Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v3i2.22200>
- Storla, D. G., Yimer, S., & Bjune, G. A. (2008). A systematic review of delay in the diagnosis and treatment of tuberculosis. *BMC Public Health*, 8, 1–9. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-15>

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang mu	Alokasi Waktu (jam/hari)	Uraian Tugas
1	Apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm / 0615039301	STIFERA	Manajemen Farmasi	5 jam	• Membuat skema pengabdian • Menyusun proposal • Melakukan penyuluhan PKM • Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
2	Apt. Margaretno Priamsari, M.Sc	STIFERA	Biologi Farmasi		• Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
3	Apt. Metrikana Novembrina, M. Sc	STIFERA	Farmakologi	5 jam	• Menyusun kesimpulan • Menyusun laporan akhir • Menyusun artikel ilmiah hasil PKM
4	Margaretha Hendrika Helmina Leong	STIFERA	DIII Farmasi	5 jam	• Administrasi → penyebaran daftar hadir dan pembagian souvenir • Dokumentasi
5	Theresia Chlarita Lavanto	STIFERA	DIII Farmasi	5 jam	• Administrasi → penyebaran daftar hadir dan pembagian souvenir • Dokumentasi

2. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri

Nomor 1 : Ketua

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
2	Jenis Kelamin	P
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	07051973
5	NIDN	0615039301
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bajawa, 15 Maret 1993
7	E-mail	eleonorareth@gmail.com
8	Nomor Telepon/Hp	085336094055
9	Alamat Kantor	Jl. Medoho III No.2, Siwalan, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =...orang, S-2 =...orang, S-3 =...orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	1. Pelayanan farmasi; Kelas = 2RA, 2RB, 2KB, 2KA
		2. Farmastika II; Kelas = 4RB, 4KA
		3. Farmasi Rumah Sakit; Kelas = 4RA

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Setia Budi	Universitas Setia Budi
Bidang Ilmu	Farmasi Komunitas dan Klinik (FKK)	Farmasi Sains
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2015-2017
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus australis</i> Poir.) Terhadap Kadar HDL dan Sel Busa Tikus Putih Jantan Galur Wistar	Uji Aktivitas Fraksi-fraksi Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus australis</i> Poir.) Terhadap Profil Lipid Darah dan Aterosklerosis Tikus Putih Jantan Yang Diberi Diet Tinggi Lemak dan PTU

Nama Pembimbing/Promotor	1. Dr. Gunawan Pamudji W., M. Si., Apt 2. Dr. Rina Herowati, M. Si., Apt	1. Dr. Rina Herowati, M. Si., Apt 2. Dr. Arief Nurrochmad, M.Si., Apt
--------------------------	---	--

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta RP)
1	2016	Uji Aktivitas Fraksi-fraksi Ekstrak Etanol Daun Murbei (<i>Morus australis</i> Poir.) Terhadap Profil Lipid Darah dan Aterosklerosis Tikus Putih Jantan Yang Diberi Diet Tinggi Lemak dan PTU	Dana Pribadi	± Rp 5.000.000

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Aktivitas Fraksi Ekstrak Etanol Daun Murbei Terhadap Profil Lipid Darah dan Aterosklerosis Tikus Yang Hiperlipidemia	JFSI	Vol.2 No.1, Oktober Tahun 2019

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
dst			

F. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-	-	-	-
dst				

G. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-
dst				

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5

Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-
dst				

I. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)

No	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
dst			

Nomor 2 : Anggota

1. Anggota (1)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	0617107902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang / 17 Oktober 1979
7	E-mail	marga_rhee@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/Hp	081542341212
9	Alamat Kantor	Jl. Medoho III / 2
10	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Farmakognosi - Fitokimia
		2. Botani Farmasi
		3. Biokimia
		4. Biologi Sel dan Molekular

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sanata Dharma	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Farmasi	Obat Bahan Alam
Tahun Masuk-Lulus	1998 - 2002	2012 - 2014
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Uji Daya Sedatif Minyak Atsiri Rimpang Bengle (Zingiber purpureum, Roxb) Pada Mencit Jantan.	Pengaruh Kombinasi Daun Sambung Nyawa, Senna dan Rimpang Kunyit Terhadap Dislipidemia, Plak Aorta dan Perlemakan Hati Pada Tikus yang diinduksi PTU
Nama Pembimbing/Promotor	1. Prof. Dr. C.J Soegiharjo, Apt 2. Dr. Phebe Hendra, M.Si	1. Dr. Ika Puspitasari M.Si, Apt. 2. Dr. Arief Nurochmad, M.Si., Apt

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta RP)
1	2019	Aktivitas Antifungi Ekstrak Etanolik Daun dan Buah Parijoto (<i>Medinilla speciosa</i>) Terhadap <i>Candida albicans</i> Secara In Vitro	Politeknik Katolik Mangunwijaya	5.000.000,-
2	2019	Analisa Karakteristik Mutu dan Identifikasi Fenol dalam Sabun Cair Berbahan Dasar Minyak Goreng Bekas dan Kulit Buah Manggis (<i>Garcina mangostana</i> L.)	Politeknik Katolik Mangunwijaya	5.000.000,-
3	2018	Analisis Kandungan Vitamin E pada Sabun Berbahan Dasar Bekatul dan Minyak Goreng Bekas	Politeknik Katolik Mangunwijaya	5.000.000,-
4	2018	Skrining Fitokimia dan Uji Toksisitas Ekstrak Etanolik Daun Sambung Nyawa Dengan Metode <i>Brine Shrimp Letality Test</i> (BSLT)	Akademi Farmasi Theresiana	5.000.000,-

5	2017	Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kualitas Ekstrak dan Kadar Flavonoid Total Daun Sambung Nyawa (<i>Gynura procumbens</i> (Lour) Merr.))	Akademi Farmasi Theresiana	5.000.000,-
6	2017	Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng Bekas dan Bekatul menjadi Sabun Mandi Herbal <i>Antiaging</i>	Akademi Farmasi Theresiana	5.000.000,-

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

11	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	In Vitro Antibacterial Activity of The Etanolic Extract of <i>Morinda citrifolia</i> L. Leaves Against <i>Stephtococcus pyogenes</i>	Journal of Pharmacy Stikes Nasional Surakarta	2020
2	Analisis Cemarkan Mikroba Pada Jamu Gendong Kunir Asem Yang Beredar di Wilayah Semarang Utara	Jurnal Akademi Farmasi Prayoga-Padang	2020
3	Aktivitas Antibakteri Ekstrak Perasan Daun Mengkudu (<i>Morinda citrifolia</i> L.) Terhadap <i>Escherichia coli</i> Secara <i>In Vitro</i>	Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia – APDFI	2020
4	Utilization of Used Cooking Oil Waste and Rice Bran Into Antiaging Soap	Journal of Pharmacy Stikes Nasional Surakarta	2019
5	Phytochemical Sreening and Activity of Ethanolic Extract (<i>Morinda citrifolia</i> L.) Against Healing Burn in Rabbit Skin	Journal of Pharmacy Stikes Nasional Surakarta	2019
6	Uji Daya Antiinflamasi Ekstrak Etanolik Kulit Terong Belanda (<i>Solanum betaceum</i> Cav) pada Mencit Jantan yang Diinduksi Karagenin	Jurnal Farmasi Klinik – Unwas	2019

7	Uji Daya Analgetik Kulit Terong Belanda (<i>Solanum betaceum</i> Cav) Pada Mencit Jantan yang Diinduksi Asam Asetat 1 %	Jurnal Akademi Farmasi Prayoga-Padang	2019
8	Pemberdayaan Ibu-ibu PKK Desa Sidorejo (Pengolahan Limbah Minyak Goreng Bekas Menjadi Sabun Cair)	Indonesian Journal of Community Services – Unisulla	2019
9	Analisis Pengaruh Perendaman Larutan Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta</i> Cortex) terhadap Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dalam Kerang Darah (<i>Anadara granosa</i>)	Media Farmasi Indonesia – Stifar Yayasan Pharmasi	2017

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-
2			

F. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-	-	-	-
2	--	-	-	-

G. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

I. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)

No	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-

2. Anggota (2)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	apt. Metrikana Novembrina, M.Sc
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	AA
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	071115020
5	NIDN	0619118601
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bengkulu/ 19-11-86
7	E-mail	Metri.kana@yahoo.com
8	Nomor Telepon/Hp	089673697878
9	Alamat Kantor	Jalan Medoho 3 nomor 2, Semarang
10	Nomor Telepon/Faks	024 6747012
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 =...orang, S-2 =...orang, S-3 =...orang
12	Mata Kuliah Yang Diampu	1. praktikum farmakologi eksperimental
		2. farmasi rumah sakit
		3. farmakoterapi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	USB	UGM
Bidang Ilmu	Ilmu farmasi	Farmasi klinik
Tahun Masuk-Lulus	2005-2009	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Optimasi Formula Tablet Kunyah Ekstrak Kelopak Rosela (<i>Hibiscus Sabdariffa</i> L.) Dengan Kombinasi Avicel PH 102 dan Laktosa Super Tab secara <i>Simplex Lattice Design</i> (SLD), Skripsi tahun 2009	Pengaruh Pemberian Simvastatin Pagi Versus Malam Terhadap Penurunan Kolesterol Pada Pasien Hiperkolesterolemia Rawat Jalan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Tesis tahun 2015

Nama Pembimbing/Promotor	Apt. Widya, S.Farm, apt. Cokro Rhadiwanto, S.U. M.S	Prof. Zullies Ikawati, Apt, dr. I Dewa Putu Pramantara, Sp. PD., K.Ger.
--------------------------	---	---

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta RP)
1	2016	EVALUASI TERAPI ANTIDEPRESAN PADA PASIEN DENGAN GEJALA DEPRESI DI RSJD AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG	Intern stifera	Rp. 4.000.000
2	2017	UJI PRAKLINIK DAN KLINIK ELECTROLYZED REDUCED WATER (ERW) SEBAGAI ANTIOKSIDAN TERHADAP STRES OKSIDATIF PADA DIABETES MELITUS	Pendanaan dikti	
3	2019	UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL 70% EKSTRAK KAWISTA (Limonia acidissima) SEBAGAI TONIKUM PADA MENCIT JANTAN GALUR SWISS	Intern stifera	Rp. 4.000.000
Dst				

*tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun sumber lainnya

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL 70% EKSTRAK KAWISTA (Limonia acidissima) SEBAGAI TONIKUM PADA MENCIT JANTAN GALUR SWISS	JFSI	Vol 2 No. 1
dst			

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
dst			

F. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Farmakologi eksperimental dan cara analisis data	2020	55	
2				
dst				

G. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
dst				

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
dst				

I. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)

No	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
dst			

3. Anggota (3)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Margaretha Hendrika Helmina Leong
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Status	Mahasiswa
4	NIM	NIM : A1192135
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Maumere, 10 Maret 2001
6	E-mail	margarethahelmina@gmail.com
7	Nomor Telepon/Hp	081236221461
8	Afiliasi	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
8	Alamat Kantor	Jl. Medoho III / 2
9	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012

4. Anggota (4)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Theresia Chlarita Lavanto
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Mahasiswa
4	NIM	A1192136
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kalabahi Alor 09 Agustus 2001
6	E-mail	Chlarita.lavanto01@gmail.com
7	Nomor Telepon/Hp	081237669670
8	Afiliasi	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
9	Nomor Telepon/Faks	(024) 6747012
10	Alamat	Jl. Medoho III / 2

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajian Hibah Internal.

Semarang, 11 Juni 2021

Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat,

apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm
NIDN: 0615039301

3. Surat Tugas



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

Jl. Medoho III No. 2 Semarang, telp. 024 6747012

Website: www.stifnusa.ac.id; e-mail: lppm.stifnusa@gmail.com



SURAT TUGAS

No : 001/ST-LPPM/V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.

Jabatan : Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

Memberikan tugas kepada :

No	Nama	Peran	Keterangan
1.	apt.Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm	Ketua	Dosen / NIDN 0615039301
2.	apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	Anggota	Dosen / NIDN 0617107902
3.	apt. Metrikana Novembrina, M. Sc	Anggota	Dosen / NIDN 0119118601

Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

Judul :Penyuluhan Pengaruh *home pharmacy care* Terhadap Penyakit Tuberkulosis
di Masa Pandemi Covid-19

Tempat : Desa Kalisegoro, RT 03 / RW 02, Gunung Pati, Semarang

Hari/Tanggal : Minggu, 30 Mei 2021

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

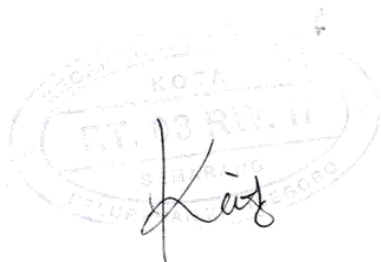
Semarang, 29 Mei 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang

Ketua LPPM,

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal M.Farm.

NIP. 071117057



4. Brosure

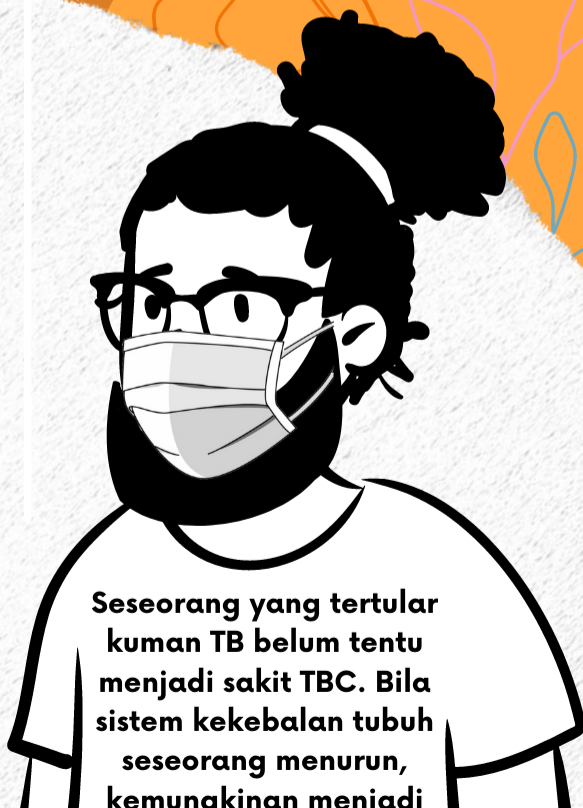


APAITU TUBERKULOSIS

Tuberkulosis (TB) / dikenal TBC merupakan penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama *Mycobacterium tuberculosis*. TB juga dapat menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan

Penularan Penyakit

- 1- Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TB paru aktif batuk, berteriak, tertawa, atau bersin
- 2- Percikan dahak dan liur yang terbawa udara sebagai media penularan
- 3- Kuman TB mampu bertahan di ruang yang lembab dan kurang sinar matahari



Seseorang yang tertular kuman TB belum tentu menjadi sakit TBC. Bila sistem kekebalan tubuh seseorang menurun, kemungkinan menjadi

Tanda & Gejala

1. Batuk lebih dari 2 minggu
2. Batuk disertai darah
3. Berkeringat di malam hari tanpa sebab
4. Demam lebih dari 38°C
5. Penurunan berat badan secara

SIAPA YANG BERISIKO TERTULU

1. Kontak erat dengan penderita TBC
2. Perokok
3. Tinggal di ruangan penuh dan lembab
4. Orang dengan HIV dan AIDS
5. Peminum alkohol
6. Usia lanjut
7. Penderita diabetes

APAKAH TB BISA DISEMBUHKAN

BISA DISEMBUHKAN, DENGAN MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (OAT) HINGGA DINYATAKAN SEMBUH. BIASANYA DENGAN PENGobatan SELAMA 6 BULAN PERTAMA (TAHAP AWAL)

MISAL; RIFAMPISIN, INH / ISONIAZIDE, ETAMBUTOL, PYRASINAMID, STREPTOMYCIN
TAHAP LANJUTAN : PASIEN MENDAPAT SEDIKIT OBAT, NAMUN PENGobatANNYA MEMERLUKAN WAKTU YANG LEBIH LAMA SEHINGA MENCEGAH TERJADINYA KEKAMBUHAN.

CARA PENCEGAHAN

1. PENDERITA

MINUM OBAT SAMPAI HABIS
MENUTUP MULUT KETIKA BATUK/BERSIN
TIDAK MELUDAH SEMBARANGAN TEMPAT

2. KELUARGA

JEMUR KASUR SEMINGGU 1X
BUKA JEDELA, AGAR SIRKULASI UDARA
DAN MATAHARI MASUK

3. LAINNYA

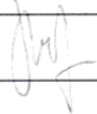
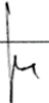
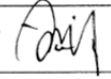
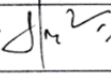
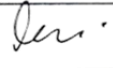
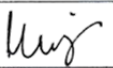
IMUNISASI BCG
MAKAN-MAKANAN BERGIZI
POLA HIDUP SEHAT
JAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN & RUMAH
PASTIKAN VENTILASI CUKUP AGAR
ALIRAN UDARA LANCAR

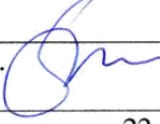
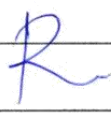
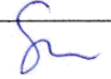
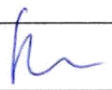
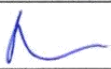
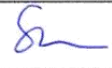
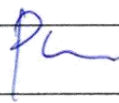
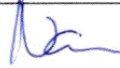
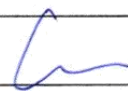
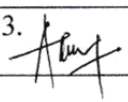
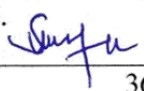


5. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR IBU-IBU PKK

Desa Kalisegoro, RT 03 / RW 02, Gunungpati, Semarang

No	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	LISTIYANI	1. 
2	KARTI	2. 
3	KARNI	3. 
4	SRI WAHYU	4. 
5	B. Wardiyah	5. 
6	KRIS Siswaningsih	6. 
7	Sumarni	7. 
8	Nartik	8. 
9	Narti	9. 
10	SRI Fakhimah	10. 
11	Maryatin	11. 
12	TARI	12. 
13	Dwi	13. 
14	wati ufomo	14. 
15	Ana	15. 
16	Wahyu	16. 
17	Munjayanah	17. 
18	Kus	18. 
19	Martiah	19. 
20	desi	20. 

21	Saturni	21. 
22	Rismawati	22. 
23	atik	23. 
24	Sridarso	24. 
25	Meta	25. 
26	Nur azizah	26. 
27	Sri Hartini	27. 
28	Partini	28. 
29	Nariyati	29. 
30	Ngasiyati	30. 
31	Ratemi	31. 
32	Tuliana	32. 
33	Aulia Nur	33. 
34	Eli Erawati	34. 
35	Sarmin	35. 
36		36.
37		37.
38		38.
39		39.
40		40.
41		41.
42		42.
43		43.

6. Foto-foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



7. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PKM 2021 - 2021

apl. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm

No.	TANGGAL	KEGIATAN	JUMLAH	
	27-May-21	Pemasukan dana pengabdian 100%	Rp	3.000.000
			Total Pemasukan	Rp 3.000.000
		Pengeluaran		
1	21-May-21	Pencetakan Brosure	Rp	203.000
		Edit Brosure	Rp	100.000
2	30-May-21	Snak	Rp	262.500
3	30-May-21	Aqua	Rp	44.500
		Perjalanan		
4	11-May-21	Survei lokasi	Rp	24.000
	26-May-21	Pembelian Souvenir	Rp	27.000
	30-May-21	Grabcar pergi-pulang	Rp	146.000
5	17-Mar-21	Souvenir : Tikar dan Jumbo	Rp	260.000
6	23-Apr-21	Fotocopy dan jilid proposal	Rp	35.000
7	27-May-21	Administrasi	Rp	500.000
8	27-May-21	Biaya reviewer	Rp	200.000
		Honor		
9	30-May-21	Ketua PKM	Rp	200.000
		Anggota 1 dan 2	Rp	200.000
		Anggota 3 dan 4	Rp	100.000
10		Publikasi	Rp	698.000
			Total Pengeluaran	Rp 3.000.000
			Sisa	Rp -

Mengetahui :

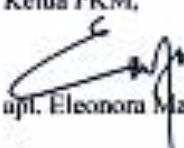
Puket II



apt. Atalia Tinto Ina Bula, M.Farm

Semarang, 30 Mei 2021

Ketua PKM,



apt. Eleonora Maryeta Toyo, M. Farm

Ketua STIFERA



apt. Yithro Serang, M.Farm.

No	Nama Barang	Qty	atau Harga Jual
1	Cetak : Nama Item : ART Paper 120 Gram (323 X 485cm) Job Name : BROSUR STOP TUBERCULOSIS CETAK 50 LMBAR BB AP 120+ LIPAT + POTONG (50 X 3.200 = 160.000) Finishing : Potong (1 X 10.000 = 10.000) Lipat (1 X 30.000 = 30.000)	50	200.000

KASH	Subtotal	200.000
UNIVAS	Discount	0
JORJONA PRIMERI	Ongkos Kirim	0
DIKALFA	Total DP	0
2163/202112.38.55	GRAND TOTAL	200.000

Ket 50 : + LIPAT + POTONG
COM VIP 02
MUMPHI / PM 2130.

Perhatian :

1. Kupon maksimal 3 hari setelah barang diambil
Terdapat 3 hari kami tidak menerima kupon.
2. Barang yang tidak diambil dalam waktu 30 hari, segara
beres.

Kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab CV.

+ parkir 3.000
203.000

	No. _____	①
	Telah terima dari <u>Ketua PKM</u>	
	Uang sejumlah <u>Seratus ribu rupiah</u>	
	Untuk pembayaran <u>Edit Brosure Penyelesaian Penyakit TB</u>	
		Sabtu, 15 Mei 2021
	Rp. <u>100.000,00</u>	 Achmad Mahdi M.



43.50201

SPEL LAMPER TENGAH

A. LAMPER TENGAH

Shift: 2 No. Trans: 54799

Waktu: 11/05/2021 14:20:02

Pulau/Posisi: 6

Nama Produk: PERTAMINA

Harga/Liter: Rp. 9.000

Volume: 1 Ltr 2.651

Total Harga: Rp. 23.859

Operator: AFRI

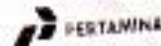
CASH

23.859

24.000

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SEMOGA SELAMAT SAMPAI TUJUAN



44.50208

STOU KEDAH PERBU

ULTENTAH SELAMAT

Shift: 2 No. Trans: 27036/08

Waktu: 26/05/2021 11:22:07

Pulau/Posisi: 5

Nama Produk: PERTAMINA

Harga/Liter: Rp. 9.000

Volume: 1 Ltr 2.940

Total Harga: Rp. 26.460

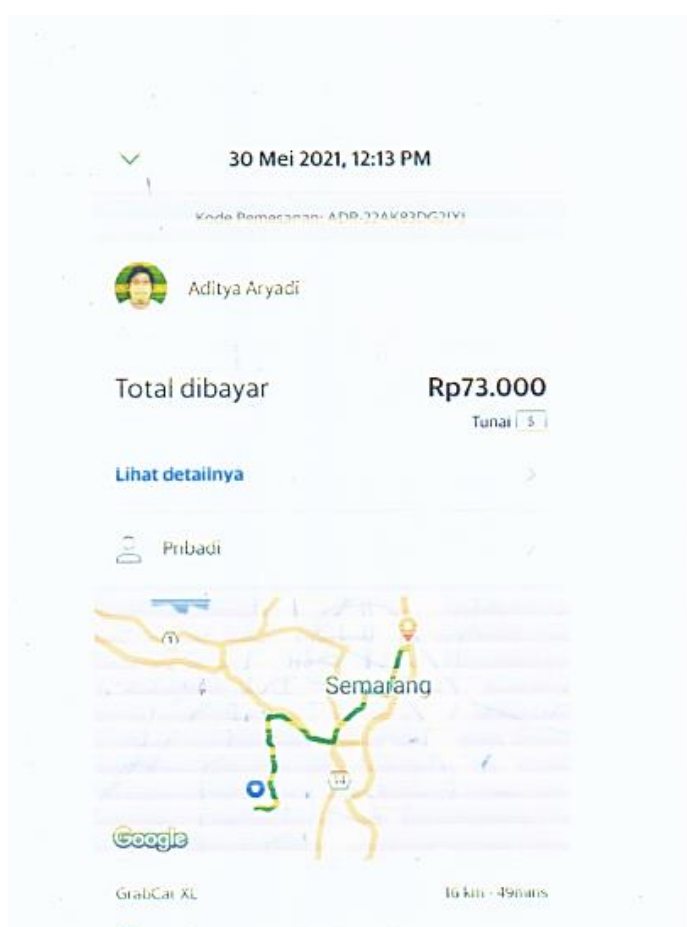
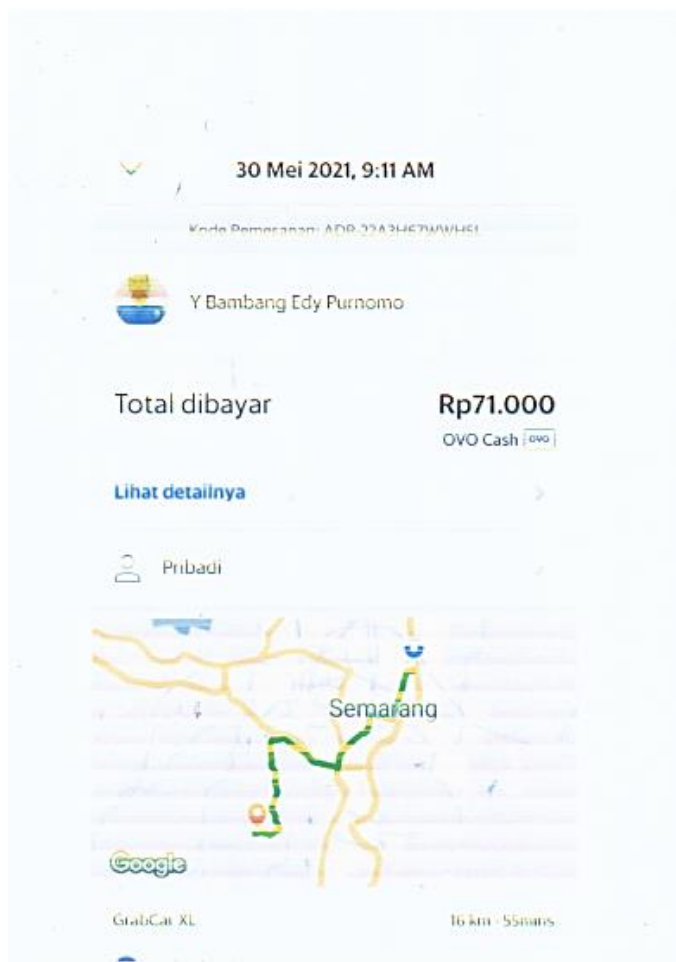
Operator: OPERATOR

CASH

26.460

27.000

TERIMA KASIH
SELAMAT JALAN



5

Untuk Tuan 27/12
Toko 1

Nota No. _____

Banyak Rak	NAMA BARANG	Harga	Jumlah
1	Arizona 20L		170 on
1	Tipat mending		85 on
			255 on
	⊕ Pantair		8 on
			260 on

Tanda terima _____

Jumlah Rp. 260.000
S. E. & O

6

IOSSS COMP COPY & ADVERTISING

DESIGN, PRINTING, OFFSET & GARMENT

Jl. Lempur Mijen RT 3 RW 5 Hm 11
Kud. Lempur Tengah
email : jress.comp.copg.advertising@gmail.com
HP/WA : 8008 4001 5031

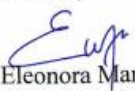
NOTA NO. _____

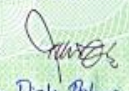
Semarang, 23 / 01 / 2020
Kepada Yth. _____

Ditujukan : Brosur, Buku, Brosur, Kip, Kue,
Kalender, Kartu Nama, Label, Stiker,
Kardus, MHT, Spanduk, Undak Undak,
Papan Nama, Nampan, Hupit Tertut
Cekung : Berapen, Kase, Celana, Telingan, ds

BAYARAN	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL
	Idocopy + Jilid		35 on

Jumlah Rp. 35.000

KWITANSI	
No. _____	
Telah terima dari	: Ketua PKM an. apt, Eleonora Maryeta T.,M. Farm
Uang sejumlah	: Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
Untuk pembayaran	: Administrasi; Perizinan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Ketua PKM,	Semarang, 27 Mei 2021
 apt. Eleonora Maryeta T.,M. Farm	Yang Menerima,  Ketua RT

	No. 18
	Telah terima dari apt. Rizky Ardian Hartanto Sawaal, M.Farm. (Ketua LPPH)
	Uang sejumlah Dua ratus ribu rupiah
	Untuk pembayaran Biaya reviewer pengabdian a.n. apt. Eleonora Maryeta T.,M. Farm.
	Semarang,
Rp. 200.000,-	 apt. Poppy Diah Palapi, M.Sc.

9

No. 5	Telah terima dari Ketua PKM
Dang sejumlah Dua ratus ribu rupiah	Untuk pembayaran Honor Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ketua
	Minggu, 30 Mei 2021
Rp. 200.000,00	apt. Eleanora Margeta T., M.Farm

No. 1	Telah terima dari Ketua Pengabdian Kpd. Masyarakat
Dang sejumlah Seratus ribu rupiah	Untuk pembayaran Honor Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
	Minggu, 30 Mei 2021
Rp. 100.000,00	apt. Margareta Retno P., M.Sc

No. 2	Telah terima dari Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat
Dang sejumlah Seratus ribu rupiah	Untuk pembayaran Honor Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
	Minggu, 30 Mei 2021
Rp. 100.000,00	apt. Melrikana Novembina, M.Sc

No. 4
Telah terima dari Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat
Uang sejumlah Lima puluh ribu rupiah
Untuk pembayaran Honor kegiatan pengabdian kepada
Masyarakat
Minggu, 30 Mei 2021
Rp. 50.000,00
Theresia Charita Lavanto

50